



EPICRISIS CARLOS OCANDO

Nombre : Carlos Ocando Azuaje
Rut : 26.675.657-7
Edad : 51 años.
Previsión : Isapre Banmedica.
Fecha de ingreso : 06/09/2023
Fecha de egreso : 21/12/2023

• **Antecedentes Mórbidos:**

- DM II
- SOBREPESO

• **Quirurgicos:**

- Enfermedad de Hirschsprung en la infancia: cirugía de colon

• **Hábitos:** - TBQ (-) – OH (ocasional) – Drogas (-).

• **Medicamentos:** Metformina 850mg cada 12horas

• **Alergias:** negativo

• **Antecedentes epidemiológicos:** BLEE, VIM

• **Diagnósticos:**

1. Hemorragia intracerebral cerebelosa
2. Fístula AV dural vermiana rota embolizada 14/06
3. Craniectomía fosa posterior 14/06
4. DVE (retirado)
5. Infección sitio quirúrgico 28/06
6. VMI prolongada / TQT 29/06
7. Íleo médico

ANAMNESIS



Cambio de posición c/2 hrs

Realizar cambio de pañal cada vez que sea necesario para evitar dermatitis asociada a incontinencia/humedad.

Realizar cuidados de gastrostomía

Ventilación del hogar.

Fomentar la inducción del sueño: Al momento de dormir, eliminar distractores, favorecer un ambiente óptimo para conciliar el sueño

EPICRISIS

Fecha de Impresión:
22/12/2023 00:07
Impreso por:
CARLOS EDUARDO TORRES BERRÍOS

Paciente : OCANDO AZUAJE CARLOS EDUARDO
Identificación: 26.675.657-7
Edad : 52 A 2 M 9 D

N°Admisión : 4051
Previsión : ISAPRE BANMEDICA S.A.
Convenio : CAEC

N°Cargo :
F.Ingreso : 22/09/2023 11:24
F.Egreso : 22/12/2023

Diagnósticos de Ingreso

1) TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CABEZA

Diagnósticos de egreso

CIE10 1) I69 - SECUELAS DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR

Libre: ACV HEMORRAGICO X MAV ROTA

Resumen de evolución clínica

HISTORIA CLÍNICA

Previamente sano, Ingeniero informático. Rankin 0.

El 13/06 a las 15:00 inicia cuadro de cefalea ictal y vértigo asociado a síntomas neurovegetativos y trastorno del equilibrio. Acude a Clínica Santa María donde es evaluado por neurología donde se describe disimetría bilateral sin otras alteraciones. Se realiza RM encéfalo que muestra HSA fosa posterior, imagen sugerente de MAV vermiana asociado a hidrocefalia. Se comenta caso con neurocirugía y neuroradiología intervencional, se acuerda ingreso a pabellón de hemodinamia pero en este contexto presenta deterioro de nivel de conciencia y postura descerebración a izquierda. Se lleva a TAC de encéfalo que muestra resangrado e hidrocefalia

Angiografía cerebral: 14/06: Fístula AV dural vermiana rota tipo 3 Merland, se procede a embolización prequirúrgica de urgencia logrando completa exclusión endovascular. Al mismo tiempo se realiza craniectomía suboccipital e instalación de DVE.

Desde el punto de vista clínico presenta mejoría leve pero progresiva, pero posteriormente con aumento nuevo de tamaño ventricular por lo que se realiza segunda instalación de DVE frontal. Ambos DVE muestran en hemorragia de trayecto. Se decide traslado para continuar manejo en Clínica Davila por motivos previsionales. Como incidencia, durante la hospitalización Clínica Santa María evoluciona sin emisión de deposiciones por lo que requirió 2 colonoscopías evacuadoras.

Es ingresado a Clínica Davila el 07/07/23, evolucionando por especialidad:

Neurología: Inicialmente estable, pero de forma progresiva presenta deterioro neurológico asociado a ausencia de deposiciones y abdomen distendido. Se realiza TAC de cerebro que muestra dilatación ventricular. Se decide instalación de DVE parietal derecho con mejoría clínica marcada. Por lo anterior se decide instalación de DVP definitivo. Presenta nuevo episodio de deterioro neurológico asociado a dilatación ventricular, revisándose DVP con laparotomía exploradora mostrando que salida de DVP estaba inmerso en brida que se resuelve. Posteriormente evolucionó favorablemente encontrándose vigil, bradipsíquico, nómima, repite, comprende órdenes simples, vocaliza, hemiparesia izquierda y parkinsonismo generalizado. El día 28/08 se logra decanular sin complicaciones

Infeccioso: Empiema por E. Coli drenado, en cobertura antibiótica con ceftriaxona con buena respuesta clínica y de laboratorio. Completa 21 días. Durante evolución cursa con múltiples complicaciones infecciosas principalmente en contexto de TQT prolongada. 14/08 evoluciona subfebril por lo que se pancultiva nuevamente destacando CAET: Hubo desarrollo de > 1.000.000 UFC/ml de Achromobacter denitrificans, completa 7 días de Tazonam. Actualmente sin incidencias infecciosas con curva febril negativa y parámetros inflamatorios bajos

Durante su evolución recibe rehabilitación multimodal y en últimos días con asistencia diaria a gimnasio. Dada extrema dificultad para evacuar deposiciones, se ha mantenido con sonda rectal. Dado que paciente se encuentra estable se decide traslado a CLC el 06/09/23 para continuar con neurorrehabilitación intensiva.

Exámenes complementarios realizados en CD:

TAC cerebro 08/07: Cambios postquirúrgicos de craniectomía occipital posterobasal con una extensa colección hipodensa yuxtadural residual en la fosa posterior parcialmente visible, que alcanza un espesor de hasta 35 mm. Material de embolización denso vermiano parasagital izquierdo. Hematomas intraparenquimatosos de evolución subaguda frontales bilaterales, el derecho de mayor tamaño y aspecto más reciente, con edema vasogénico circundante, signos de vaciamiento y consecuente hemoventrículo hacia las astas occipitales de ambos ventrículos laterales. Trayectos hipodensos de drenajes ventriculares frontales bilaterales ya retirados.

TAC TAP 08/07: Instalación de sonda endorrectal. Se ha resuelto la dilatación en rango patológico de asas intestinales. Resolución de la ascitis. Resto del estudio sin cambio significativos a destacar. Luego evoluciona afebril con PI bajos, por lo que se decide mantener el manejo con ceftriaxona.

EEG 10/07: lentitud delta generalizada, simétrica, intermitente, de profundidad moderada a severa. Sin actividad epileptiforme. El 10/07 neurología indica modafinilo para optimizar rehabilitación. Ingres a UTIN el 11/07, HDN estable, afebril.

El 06/09/23 se trasladó a Clínica Los Coihues para continuar rehabilitación. En la clínica presenta episodio de desorientación y agitación psicomotora por lo que se decide su traslado a Clínica Dávila. Al examen neurológico de ingreso sin cambios destacables con respecto al alta anterior, se complementa estudio con TAC de encéfalo que no muestra signos de disfunción de válvula ni complicaciones intracraneales y se realiza EEG que no muestra actividad epileptiforme. Dentro de exámenes generales de ingreso destaca orina completa inflamatoria y urocultivo + para E Faecium sensible a linezolid. Evaluado por infectología se decide tratamiento ATB ev con dicho antibiótico por 5 días. Curva febril negativa y parámetros inflamatorios persistentemente bajos.

Dado positiva evolución reingresa a CLC el 22/09/23 para continuar proceso de rehabilitación

ANAMNESIS ACTUAL:

Paciente en BCG, con alimentación enteral por GTT y con sonda rectal. Al día de hoy destaca paciente:

Dolor: Niega dolor al interrogatorio dirigido. Durante realización de examen físico sin foci dolorosos. v tampoco lo refiere.

mo: Actualmente con antidepresivo, por episodio de labilidad emocional en UCL Actualmente sin
Manejo vesical: Espontáneo en pañal. En ocasiones avisa cuando se encuentra con esposa.
Manejo intestinal: Se encuentra utilizando sonda rectal.

EXAMEN FÍSICO

Epidemiológico: BLEE y VIM.

Ventilación: Espontánea

Alimentación: Mixta; Por GTT

M. vesical: Espontánea, en pañal

M. intestinal: Con sonda rectal.

General: En buenas condiciones generales. Hipofónico.

Piel: Buenas condiciones. GTT en buenas condiciones.

Cognitivo: Vigil, desorientado temporo espacial, bradisíquico, no invierte series simples, repite frases, fluencia normal y nominación 4/5, sigue instrucciones simples de 1 comando, dificultad para las de 2. memoria inmediata conservada, mediata ? y largo plazo 3/3.

Pares craneales: Pupilas isocóricas, con respuesta a reflejo fotomotor y consensual, CV conservado, con sensibilidad facial conservada simétrica, sin desviación facial, sin nistagmo patológicos, sin desviación lingual y paladar eleva simétricamente. resto de PC sin alteraciones.

EES

ES Derecha: Fuerza M4. Tono N. Reflejo simétricos. Sensibilidad conservada.

ES Izquierda: Fuerza M3 a nivel de hombro, m4 en codo y muñecas. Tono ash 1 en extensores de codo y en flexores de muñeca. Reflejos simétricos. Sensibilidad levemente disminuida.

EEl

EID: Fuerza M4 en caderas, al menos m3 en rodilla, y m4 en plantiflexores. Tono sin alteración. ROT amplitud y area. Clonus(+) rápidamente fatigable. RCP indiferente. Sensibilidad levemente disminuida.

EII: Fuerza M4 en caderas, al menos m3 en rodilla, y m4 en plantiflexores. Tono Ash 1 en aductores, resto sin alteración. Clonus(+) no fatigable. RCP extensor. Sensibilidad no alterada.

Cerebeloso: Con dismetría y con disdiadococinesia pronunciada a izquierda

Control postural: Presenta control cefálico, logra giro independiente hacia ambos lados, asimismo requiere asistencia moderada para transición de decúbito a sedente. Con KTM se logra bipedestación con asistencia moderada y marcha en el lugar.

DIAGNÓSTICOS INGRESO CLINICA LOS COIHUES (CLC)

1. Hemorragia intracerebral de fosa posterior (13/06/23)
 - a. Fístula AV dural vermiana rota, embolizada 14/06/23
 - b. Craniectomía fosa posterior 14/06
 - c. DVE (retirado el 30/06) - hidrocefalia tardía, instalación DVP 30/07
 - d. Hematomas intraparenquimatosos frontales bilaterales en relación a DVE retirados
2. Infección sitio quirúrgico peridural
- Empiema drenado (28/06) + tratamiento ATB por 21 días
3. VMI prolongada/ Trastorno deglutorio severo /GTT (24/07)
 - a. TQT 29/06. Decanulado 29/08/23
4. Enfermedad de Hirschsprung operada
6. Antecedentes: DM2, Obesidad

DEFICIENCIAS

1. Trastorno motor:
2. Tetraparesia leve de predominio izquierdo
3. T. equilibrio intensidad severo
4. Sd cerebeloso intensidad severa
5. Trastorno deglutorio secundario a VMI
6. Disfagia Moderada a severa, nivel 2 según escala DOSS por uso de GTT
7. Trastorno sensitivo tipo hemihipoestesia izquierda
8. Trastorno cognitivo intensidad moderada
9. Trastorno comunicativo
10. Trastorno de la voz - hipofonía moderada
11. Trastorno de funciones relacionadas con la defecación: Enfermedad de Hirschsprung operada.

Limitaciones en la actividad

Dependientes en todas las AVDB

Restricción de la participación: Global

- Lograr marcha intradomicilio con asistencia y ayuda técnica.
- Estimulación cognitiva.
- 5. Aumentar Independencia en AVDB./Disminuir carga del cuidador.
- 6. Lograr alimentación vía oral completa.
- 7. Manejo trastorno comunicativo.
- 8. Regularizar tránsito intestinal.
- 9. Prevenir complicaciones por inmovilidad.

Tratamientos realizados

Paciente evolucionó sin complicaciones. Distensión abdominal disminuyó de manera efectiva con metformina 850 mg c/12 hrs.
Recibió rehabilitación intensiva con las siguientes cargas:

CARGA TERAPÉUTICA

Kinesioterapia motora: 12 semanales
Psicología: 2 veces por semana.
Kinesioterapia respiratoria: 7 veces por semana
Terapia Ocupacional: 11 semanales
Fonoaudiología: 6

Paciente evolucionó favorablemente, obteniéndose los siguientes logros:

OBJETIVOS DE REHABILITACIÓN LOGRADOS:

1. Mejorar fuerza global y lograr activación de musculatura residual: logrado, fuerza M4/5 global
2. Mejorar equilibrio: logrado.
3. Lograr marcha intradomicilio con asistencia y ayuda técnica: logrado, realiza marcha con andador y asistencia mínima.
4. Estimulación cognitiva: en proceso, aumentó ACER de 44/100 a 64/100: MMSE de 20/30 a 23/30
5. Aumentar Independencia en AVDB./Disminuir carga del cuidador: en proceso, aumentó FIM de 37/126 a 57/100.
6. Lograr alimentación vía oral completa.: en proceso: come 4 comidas por boca, pero no logra comer el volumen adecuado y por eso mantiene aporte por GTT.
7. Manejo trastorno comunicativo: mejor, logra comunicación funcional a nivel social.
8. Regularizar tránsito intestinal: logrado., metformina es fundamental para ello.
9. Prevenir complicaciones por inmovilidad: logrado, sin UPP.

DIAGNÓSTICOS EGRESO CLINICA LOS COIHUES (CLC)

1. Hemorragia intracerebral de fosa posterior (13/06/23)
2. Fístula AV dural vermiana rota, embolizada 14/06/23
3. Craniectomía fosa posterior 14/06
4. DVE (retirado el 30/06) - hidrocefalia tardía, instalación DVP 30/07
5. Trastorno deglutorio severo /GTT (24/07)
6. TQT 29/06. Decanulado 29/08/23
7. Enfermedad de Hirschsprung operada

Indicaciones

1. Régimen Mixto Blando modificado + líquidos Tipo néctar + NE nocturna (19") Glucerna 1.5 500cc a 50 cc/hr + 1000 cc agua x gtt - Dosis: 1 - Vía: Gastrostomía
2. Reposo relativo: logra marcha con un andador de dos ruedas y asistencia de una persona.
3. Bisoprolol - Dosis: 1.25 mg cada 12 hrs x GTT
4. Modafinilo - Dosis: 100 mg a las 07:00 hrs x GTT
5. Levetiracetam - Dosis: 10 ml cada 12 hrs. (se puede cambiar por Levetiracetam comprimidos de 1.000 mg 1c/12 hrs) x GTT
6. Esomeprazol - Dosis: 40 mg x GTT
7. Melatonina 3mg - Dosis: 3 comprimidos/noche x GTT
8. Ilesulpiride - Dosis: 1 cada 8 hrs x GTT
9. metformina comp 850 mg - Dosis: 1 antes de almuerzo y 1 antes de la cena x GTT
10. creatina - Dosis: 10 grs al día en 350 ml agua x GTT
11. ARIPIRAZOL 10 mg - Dosis: 1/2 comp x GTT
12. domperidona comp 10 mg - Dosis: 10 mg c/8hrs x GTT
13. Venlafaxina - Dosis: 150 mg en la mañana x GTT
14. Prucaloprida - Dosis: 2 mg c/12 hrs x GTT
15. PEG sobres - Dosis: 1 sobre c/ 8hrs - Vía: Gastrostomía (hasta 3 sobres/día, según necesidad, es para la constipación)
16. omega 3 capsulas - Dosis: 1 capsula/día - Vía: Gastrostomía
17. difenidol comp 25 mg - Dosis: 1c/8 - Vía: Gastrostomía
18. complejo vitamina B comprimidos - Dosis: 1/día - Vía: Gastrostomía

TERAPIA TERAPÉUTICA AL ALTA (POR UN MES)

Fisioterapia motora: 3 - 5 semanales

Terapia Ocupacional: 3 - 5 semanales

Fonoaudiología: 3-5 semanales

Destino Control

1 mes con fisiatra para definir carga terapéuticas.

Domicilio 1 mes con Neurocirugía para definir fecha de craneoplastia

2 meses con Neurología para control de levetiracetam (anti epileptico)

☐ Se adjunta listado de medicamentos administrados durante hospitalización

☐ Se adjuntan exámenes

Firma padente o representante legal de recepción conforme:

☐ Sí

☐ No

☐ No aplica

Dr. Carlos Torres
Médico Fisiatra
12.455.238-8

Firma médico

Dr. Carlos Torres
Médico Fisiatr
12.455.238